# EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 73626
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-11-07 12:00:00

## DATOS DEL PACIENTE:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | : RIGOBERTO ANTONIO CARO MORALES | | | RUN | : 6.034.956-8 |
| F.Nac | : 18-10-2023 | Edad | : 0 AÑO | Género | : Masculino |
| Dirección | : | | | Comuna | : NIQUEN |
| Previsión | : SIN INFORMACION | Teléfono | : 0 | | |
| Fecha Ingreso | : 2023-10-18 | Fecha Egreso | : 2023-11-07 12:00:00 | Causal | : MEDICA |
| Condición | : VIVO | Destino | : DOMICILIO | Derivación | : |

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO

## DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-ACV isquémico territorio ACM izquierdo superficial y profundo, c/TH PH-1 ganglionar basal derecho, trombolisis con TNK y trombectomía TICI 3
-FA sin TACO
-Diarrea 2° a CD leve ATB 1/10
-Bronquitis aguda, obs bacteriana en resolución

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

## COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Historia clínica
Paciente con antecedente de HTA, dislipidemia, fa sin taco, al parecer amaneció bien, estaba realizando actividades domésticas a las 09.30 y lo encuentran con compromiso de conciencia y afásico su hija a las 10:00 con compromiso estado general, afásico y con hemiplejía izquierda. Se presenta por teleNRL por ACV ventana previa toma de Tc Cerebro que evidencia TC cbo signos precoces ASPECTS 7-8. AngioTC stop M1 ACM izquierda se indica trombolisis con tenecteplase (22.5mg) y se presenta caso a HCGGB donde se decide trombectomia de ACM Izq y plastia carotida interna izq. Retorna a HCHM evaluado por NRL residente y se decide ingreso a UTI. Se mantiene con monitorizacion cardiaca, con refuerzo de Urapidil ev para alcanzar metas de PAS <140. Tac de control a las 24 hrs evidencia Infarto subagudo en territorio superficial y profundo de ACM izquierda con petequiado hemorrágico confluente en cuerpo. Se mantiene sin antiagregación plaquetaria y tromboprofilaxis. En reajuste de antihipertensivos orales, se logran más de 72 hrs sin requerimientos de Urapidil SOS. Tac de cerebro s/c del 24/10/2023 informa Control de infarto subagudo conocido de territorio superficial y profundo de ACM izquierda, con menor densidad del componente hemorrágico ganglionar izquierdo estriado. Evaluado por Neurólogo, se inicia aspirina y enoxaparina. En condiciones de traslado a sala UPAC.

Paciente en BEG, HDN estable, eupneico, afebril últimas 72h, tranquilo, impresiona sin molestias, tolera bien alimentación sólo por SNG con mejoría lenta y progresiva (sin necesidad de GTT). Sin cambios en déficit neurológico. Actualmente en 2° día ATB por diarrea por CD, con buena respuesta, sin fx de riesgo para curso grave.
Exs de lab destaca GB N, PCR en descenso, fx renal N.
Completó tto ATB por bronquitis aguda.
En vista del estabilidad clínica se decide alta a domicilio el 7/11/23, IC HODOM y control ambulatorio en policlínico de Neurología. Se difiere transitoriamente el inicio de TACO por mala funcionalidad residual a la fecha (mRS 5).

## PLAN DE MANEJO:

-IC HODOM y control ambulatorio en policlínico de Neurología
-Mantener aislamiento de contacto por 10 días

## INDICACIONES AL ALTA

1. -Aspirina 100 mg/día
2. -Atorvastatina 40 mg/noche
3. -Famotidina 40 mg/día
4. -Losartan 50 mg c/12h
5. -Amlodipino (10 mg) 1/2 comp al día
6. -Ipratropio 2 puff c/6-8 horas SOS
7. -Metronidazol 500 mg c/8h por 8 días

## EXÁMENES Y RESULTADOS

6/11/23
-Glic 126
-Crea 0.7 MDRD 110.55 Uremia 40
-AU 2.1
-PCR 26.1
-Na 134 K 4 Cl 101
-Leu 8600 Hb 11.8 Plaq 322000 Seg 69 VHS 24
-INR 1.11 TTPA 29

5/11/23
-Crea 0.7 MDRD 110.55 Uremia 48
-Alb 3.3 Ca 8.4
-PCR 25.3
-Na 138 K 3.8 Cl 105
-Leu 7300 Hb 12.1 Plaq 334000 Seg 67 VHS 28

3/11/23
-CD tox B(+) Ag(-)

31/10/23
-Crea 1 MDRD 73.25 Uremia 63
-PCR 18.9
-Na 145 K 4.3 Cl 105
-Leu 13400 Hb 12 Plaq 402000 Seg 80

27/10/23
-Alb 3.7
-Crea 0.9 MDRD 82.72 Uremia 65
-Ca 9 Na 140 K 4.6 Cl 101
-AU 4.4
-Leu 11100 Hb 11.7 Plaq 349000 Seg 72
-Procal 0.03

## OBSERVACIONES:

Ex fco general
-Perfusión e hidratación impresiona N, yug no ing, rash(-)
-Cardiaco: RR 2T no ausculto soplos
-Pulmonar: MP(+), roncus escasos espiratorios bilaterales, sin uso de musculatura accesoria
-Abd: BDI, RHA(+), no palpo masas
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos +/+

Ex neurológico:
-Mental: vigil, no emite lenguaje ni sigue órdenes
-PC: hemianopsia derecha por amenaza, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, mirada central, MOE horizontales N, ROC verticales y horizontales N, PFC der moderada, nistagmo(-), lengua central, resto n/e

-Motor: BC izq M4-5, ESD M0-1, EID M2-3, RCP extensor derecho
-Sensitivo: hipoalgesia BC der leve
-Cerebelo n/e
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO